

ZWANGSSTÖRUNGEN

CE 11 UE 5

HANDLUNGEN UND RITUALE

HANDLUNGEN UND RITUALE

- Handlungen

- „Bewusst“ ausgeführte Tat

- Rituale

- wiederholtes, immer gleichbleibendes, regelmäßiges Vorgehen nach einer festgelegten Ordnung;
- Zeremoniell

HANDLUNGEN UND RITUALE

Überlegen Sie:

- Welchen Handlungen führen Sie Gewohnheitsmäßig durch? (Bewusst, Unbewusst?)
- Welche Handlungen führen Sie durch, weil Sie diese „gerne“ machen?
- Welche Handlungen führen Sie durch, weil Ihre „Haltung“ oder die Gesellschaft dies „fordert“?
- Wie „gewissenhaft“ führen Sie diese Handlungen durch?
- Welche Handlungen wurden zu Rituale?
- Welche Rituale haben Sie bei Ihren Kursteilnehmer*innen wahrgenommen?

ZWANG

DEFINITION ZWANG

Was bedeutet Zwang und
Wer zwingt uns??

ZWANGSSTÖRUNGEN

DEFINITION

Zwangsstörungen (OCD= obsessions-compulsions Disorder) sind psychische Erkrankungen, die durch Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen gekennzeichnet sind.

Betroffene erleben unwillkürliche, intrusive (unerwünschte und Quälende) Gedanken, die Angst oder Unbehagen auslösen, und versuchen, diese durch rituelle Handlungen oder mentale Strategien zu neutralisieren.

ZWANGSGEDANKEN / ZWANGSHANDLUNGEN

- Lesen sie die Texte

- Typische Zwänge
- Mit schlechten Gedanken umgehen

- Fragestellung

- Erklären Sie den Unterschied zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen
 - Nutzen Sie Beispiele zur Erklärung
- Erklären Sie die Auswirkung von Zwangsgedanken auf das Familienleben und Soziale Umfeld
- Beschreiben Sie die Ursachen von Zwangsstörungen
- Erklären Sie die Therapieansätze

ENTSTEHUNG

- Multifaktoriell
 - Biologisches Modell
 - Psychoanalytisches Modell
 - Lerntheoretisches Modell
 - Gesellschaftskritisches Modell
 - Systemisches Modell
- Vulnerabilitäts Stress Modell
- Beginn typischerweise im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter
- Männer und Frauen ungefähr gleich häufig betroffen

DIAGNOSTIK

- Anamnese
 - Psychopathologischer Befund
 - Dauer, Art der Zwangsgedanken/-handlungen
 - Ausmaß der Beeinträchtigung
- Differentialdiagnostik / Komorbidität
 - Depression
 - Angststörung
 - Persönlichkeitsstörung
- Schweregrad
 - Verschiedene Skalen zur Erhebung = Obsessive-Compulsive Inventory (1977), Hamburger Zwangsinventar (1983), Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (1991), Padua Zwangsfragebogen (1995),
 - Erheben die Art der Gedanken, die Gefühle die durch diese Gedanken entstehen, den Grad der Beeinträchtigung die durch diese Gedanken entstehen und die Bewältigungsstrategien

THERAPIE

- Psychotherapie
 - 1. Wahl Kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsmanagement (KVT + ERM)
- Pharmakotherapie
 - Selektive Serotonin – Wiederaufnahmehemmer (SSRI)
- Kombinationstherapie
- Tiefe Hirnstimulation

WEITERE THERAPEUTISCHE ANSÄTZE

- Psychoedukation
- Selbsthilfegruppen
- Angehörigen Beratung

VERLAUF UND PROGNOSE

- Frühe Diagnose und Behandlung verbessern die Prognose
- Rückfälle sind Häufig
- Langfristige Nachsorge erforderlich

PFLEGERISCHE BEGLEITUNG

Grundvoraussetzung:

- Empathie
- Klare Regeln
- Angehörige einbeziehen
- Rituale nicht verstärken
- Zwangsinhalte nicht bewerten

PFLEGERISCHE BEGLEITUNG

Ziele:

- Sicherheit
- Selbstbestimmung
- Stabilisierung
- Förderung der Bewältigungsstrategien
- Vernetzung mit therapeutischen Angeboten

PFLEGERISCHE BEGLEITUNG

- Anamnese
- Patientenbeobachtung
- Beziehungsgestaltung
- Kommunikation
- Psychoedukation
- Alltagsförderung / Alltagsstruktur / Routine
- Förderung der Selbstwirksamkeit
- Angehörigenarbeit
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit